

Un étudiant autiste dans votre cabinet

Pour les médecins de famille, les services de santé et de santé mentale universitaires — soigner un étudiant autiste (environ 18 à 25 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un étudiant se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. L'université est une transition *massive* : nouvelle autonomie, moins de structure, espaces ouverts, travaux de groupe, pression sociale et routines perturbées. Beaucoup d'étudiants autistes s'épanouissaient sous la prévisibilité de l'école puis **frappent un mur** — burnout, anxiété ou crise lors de la première ou deuxième année. Leurs intérêts focalisés sont une force réelle ; c'est généralement le système qui les entoure qui pose problème.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Était « tout à fait ok », ne peut plus assister aux cours, se laver, manger ou fonctionner	Burnout autistique résultant de la charge cumulative d'un environnement imprévisible et à canaux multiples
Anxiété, dépression, effondrement du sommeil, troubles alimentaires	Comorbidités courantes ; également des signaux de surcharge, et non seulement une maladie primaire
Manque les cours, rate les dates limites ; semble « paresseux »	Inertie autistique + charge exécutive sous épuisement chronique
Diagnostiqué seulement maintenant, en pleine crise	L'université est un point d'identification tardive courant (la « génération perdue »)
Préfère les emails ; évite les appels, le contact visuel, les cadres de groupe	Communication sur un canal unique et littérale ; le contact écrit réduit la charge

Essayez ceci

- **Proposez des rendez-vous en ligne/téléphone ou privilégiez l'écrit ;** autorisez la présence d'un accompagnateur et l'utilisation d'un kit sensoriel.
- **Dépistez spécifiquement le burnout autistique** — épuisement, perte de compétences précédemment acquises, tolérance réduite aux stimuli — et traitez-le comme distinct de la dépression.
- **Réduisez et structurez** : plaidez pour des aménagements via le service du handicap de l'université (espace d'examen calme, prévisibilité du calendrier, instructions écrites).
- **Interrogez sur les intérêts et la récupération** — protégez l'accès à ces activités ; le repos et le fait de « faire les choses à la manière autistique » font partie de la récupération.
- **Planifiez la continuité** pendant les vacances et la transition vers la vie d'adulte ou le post-diplôme.

Évitez ceci

- Réduire la situation à un « stress d'étudiant typique » et passer à côté d'un burnout ou d'une première identification de l'autisme.

- Recommander des approches génériques de compétences sociales ou de « persévérance » qui augmentent le camouflage.
- Supposer qu'un engagement signifie un contact visuel et une fluidité verbale.

Quand demander plus de soutien

Dépistez directement la suicidalité et le burnout sévère. Orientez vers le **service du handicap/bien-être de l'université**, le mentorat et les communautés d'étudiants autistes. Envisagez une **réduction temporaire de la charge académique** ou une interruption d'études comme une étape de récupération légitime et alignée sur les preuves — et non comme un échec. Traitez les comorbidités (TDAH, anxiété, sommeil, GI).

Si l'étudiant est une femme

Les femmes et les genres marginalisés sont surreprésentés parmi les étudiants identifiés tardivement et camouflent intensément. Une présentation « performante, sociable en surface » avec un effondrement privé est un schéma clé — interrogez-vous sur l'écart entre la performance publique et l'épuisement privé.

À propos de ce guide

*Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le brief **Monotropisme** et le **Guide pour les praticiens et professionnels de santé** (Parties 3.3–3.4 & 4). Utilise le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic.** Adaptez-le à l'étudiant individuellement.*

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Pearson & Rose (2021); Knight (2021, *tunnels not tasks*); AASPIRE AHAT. Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.